OBSTETRÍCIA

Sangramentos na segunda metade da gestação | Resumo e PTS

Resumo de tutoria e plano terapêutico singular

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

12 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO · OBSTETRÍCIA

Sangramentos da segunda metade da gestação

Placenta prévia, acretismo, DPP, rotura uterina, vasa prévia e seio marginal · Conteúdo verificado em **outubro/2026** · PTS da Maria ao final

SEÇÃO 1

Visão geral e abordagem inicial

Quem sangra depois de 20 semanas pode estar perdendo sangue materno, sangue fetal ou os dois — e o primeiro gesto do médico pode salvar ou piorar a situação.

1.1 Do que estamos falando

Chamamos de sangramento da segunda metade da gestação a perda de sangue pela vagina a partir de 20 semanas (alguns autores usam 22). Nesse período, a placenta já está grande, muito vascularizada e recebe boa parte do débito cardíaco materno, de modo que um problema na sua inserção pode levar a hemorragia volumosa em minutos. As causas obstétricas que importam são seis, e cada uma tem um mecanismo próprio que explica a sua apresentação:

- **Placenta prévia** — a placenta está implantada sobre o orifício interno do colo ou muito perto dele.
- **Espectro da placenta acreta** — a placenta adere ou invade o miométrio; raramente sangra antes do parto, mas sangra muito na tentativa de retirá-la.
- **Descolamento prematuro de placenta (DPP)** — a placenta, normalmente inserida, se separa da parede antes do nascimento.
- **Rotura uterina** — a parede do útero se rompe, quase sempre sobre uma cicatriz.
- **Vasa prévia** — vasos fetais sem proteção cruzam a membrana sobre o colo; quando rompem, o sangue perdido é do feto.
- **Rotura do seio marginal** — sangramento da borda de uma placenta normalmente inserida, em geral benigno.

Antes de atribuir o sangramento a uma dessas causas, lembre que a gestante também sangra por motivos não obstétricos — cervicite, pólipo, ectrópio, lesão traumática, câncer de colo — e que a eliminação do tampão mucoso com rajas de sangue no início do trabalho de parto é fisiológica. O exame especular resolve boa parte dessas dúvidas.

1.2 A primeira regra: nada de toque antes de saber onde está a placenta

O toque vaginal digital, numa placenta prévia, pode introduzir o dedo no tecido placentário e desencadear hemorragia maciça. Por isso, em toda gestante que sangra após 20 semanas, o toque só é feito depois que a ultrassonografia afastou placenta prévia [prática consagrada]. O **exame especular é seguro** e deve ser feito: mostra se o sangue vem do colo ou de dentro do útero, estima o volume e identifica as causas locais.

1.3 Abordagem inicial — os primeiros minutos

A sequência é a mesma para todas as causas, porque o que mata primeiro é a hipovolemia materna. Avaliar a gravidade (frequência cardíaca, pressão, perfusão, nível de consciência e volume do sangramento), obter **dois acessos venosos calibrosos** e iniciar cristaloide quando há instabilidade, sondar a bexiga para medir diurese (meta acima de 30 mL/h) e colher hemograma, tipagem sanguínea com prova cruzada, coagulograma, fibrinogênio, ureia e creatinina. Ao mesmo tempo, avaliar o feto: batimentos cardíacos fetais e, quando viável, cardiotocografia.

A gestante Rh negativo não sensibilizada que sangra recebe **imunoglobulina anti-D**, porque o sangramento placentário pode passar hemácias fetais para a circulação materna [prática consagrada]. Quando há suspeita de grande hemorragia feto-materna, o teste de Kleihauer-Betke quantifica o volume e ajusta a dose.

Com a mãe estabilizada, três perguntas organizam o raciocínio: *há dor e o útero está duro?* (DPP ou rotura), *onde está a placenta na ultrassonografia?* (prévia ou não) e *o feto piorou logo após a rotura das membranas?* (vasa prévia).

> **RACIOCÍNIO CLÍNICO**
> A cor e a dor contam a história. Sangue **vermelho vivo, indolor, com útero relaxado** sugere sangue que sai livremente de vasos maternos abertos no colo — placenta prévia. Sangue escuro, com dor e útero endurecido sugere sangue que ficou retido e coagulou atrás da placenta — DPP. Sangramento logo após a amniorrexe com **sofrimento fetal desproporcional** ao volume perdido sugere que quem está sangrando é o feto — vasa prévia.

SEÇÃO 2

Placenta prévia e placenta de inserção baixa

Uma placenta no lugar errado sangra quando o útero começa a se preparar para o parto — e é essa preparação que explica por que o sangramento é indolor, recorrente e cada vez maior.

2.1 Conceito e nomenclatura atual

A classificação mudou e as provas cobram as duas versões. A nomenclatura atual usa a **distância entre a borda placentária e o orifício interno do colo**, medida pela ultrassonografia transvaginal:

- **Placenta prévia** — o tecido placentário recobre total ou parcialmente o orifício interno.
- **Placenta de inserção baixa** — a borda não recobre o orifício, mas está a **menos de 20 mm** dele.
- **Inserção normal** — borda a 20 mm ou mais do orifício.

A classificação antiga — *total* (recobre todo o orifício), *parcial* (recobre parte) e *marginal* (a borda alcança o orifício sem recobri-lo) — ainda aparece em enunciados e em protocolos brasileiros. Na prática, total e parcial correspondem à placenta prévia de hoje, e a marginal foi absorvida pela inserção baixa (Figura 1).

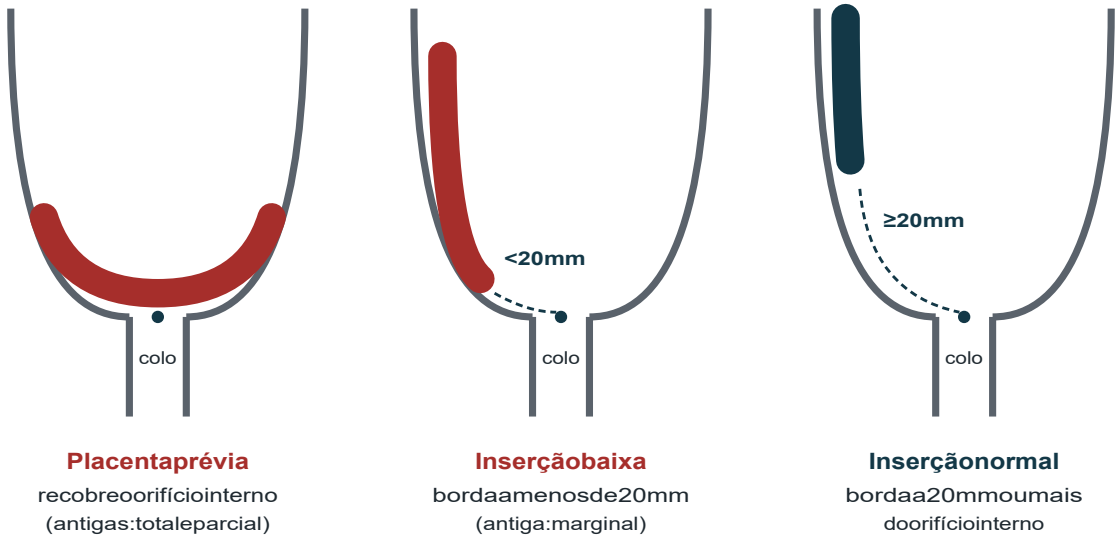


Figura 1 — Classificação da placenta pela distância ao orifício interno do colo. Corte esquemático do segmento inferior; o ponto azul marca o orifício interno. A medida é feita pela ultrassonografia transvaginal e só é definitiva no terceiro trimestre, porque a maioria das placentas baixas do segundo trimestre "sobe" com o crescimento do segmento inferior.

O diagnóstico só se firma **a partir de 28 semanas**. Até lá, o segmento inferior ainda está crescendo e afasta a borda placentária do colo — a chamada migração placentária. Cerca de 2% das gestações têm placenta baixa por volta de 20 semanas, mas a prevalência no termo cai para cerca de 4 por 1.000 nascimentos, porque aproximadamente 90% dos casos se resolvem. Por isso, a placenta baixa vista no segundo trimestre é reavaliada com nova ultrassonografia transvaginal por volta de 32 semanas.

2.2 Por que acontece — fatores de risco

O blastocisto tende a se implantar onde o endométrio está mais bem vascularizado. Quando o endométrio do corpo uterino foi lesado ou está "gasto", a implantação acontece mais abaixo. Isso explica os fatores de risco: a **cesárea anterior é o principal**, e o risco cresce com o número de cesáreas; somam-se placenta prévia anterior, curetagens e outras cirurgias uterinas, multiparidade, idade materna avançada, gestação múltipla (placenta maior, que ocupa mais área) e tabagismo. A cicatriz que favorece a implantação baixa é a mesma que favorece o acretismo — por isso placenta prévia sobre cicatriz de cesárea exige sempre a pesquisa de acretismo (seção 3).

2.3 Fisiopatologia do sangramento e quadro clínico

No terceiro trimestre, o istmo se alonga e afina para formar o segmento inferior, e as contrações de treinamento começam a apagar o colo. A placenta não é elástica: quando a parede abaixo dela se estira, a borda se descola e expõe os vasos maternos do leito placentário. O sangue sai livremente pelo colo, sem ficar retido, e por isso é **vermelho vivo**; não há hematoma distendendo o útero, e por isso o sangramento é **indolor e o tônus uterino é normal**. Como o sangue perdido é materno e a área de troca preservada é grande, o **feto costuma estar bem**, a menos que a mãe entre em choque.

O primeiro episódio é tipicamente súbito, sem desencadeante, e cessa espontaneamente — é o sangramento sentinela, mais comum entre 26 e 28 semanas. Cada novo episódio de formação do segmento repete o processo, e o sangramento tende a ser **recorrente e progressivamente maior**. Como a placenta ocupa a pelve, a apresentação fetal costuma ser anômala ou alta; no exame obstétrico, o útero é indolor e as partes fetais são facilmente palpáveis.

2.4 Diagnóstico

A **ultrassonografia transvaginal é o padrão-ouro**: é mais precisa que a via abdominal e segura, porque o transdutor fica no fórnice e não toca o colo. O exame especular é seguro; o toque é proibido até que a ultrassonografia afaste a placenta prévia. Se o sangramento vier acompanhado de contrações ou hipertonia, é preciso afastar DPP associado.

2.5 Conduta

A conduta é decidida por três fatores: o volume do sangramento e a estabilidade materna, a idade gestacional e a vitalidade fetal. A Tabela 1 resume os cenários.

Cenário	Conduta
Sangramento intenso, instabilidade materna ou sofrimento fetal	Cesárea imediata, em qualquer idade gestacional, com reposição volêmica e hemoderivados.
Sangramento que cessa, mãe estável, feto pré-termo	Conduta expectante: internação, repouso relativo, vigilância materna e fetal, corticoide entre 24 e 34 semanas, anti-D se Rh negativo e reposição de ferro. Cessado o sangramento, alta com orientação de evitar relações sexuais e retornar a qualquer novo sangramento.
Sangramentos recorrentes	Reinternação; em alguns casos, internação até o parto, com decisão individualizada.
Placenta prévia estável, sem sangramento ativo	Cesárea programada entre **36 e 37 semanas e 6 dias**, sem necessidade de documentar maturidade pulmonar [ACOG 2021].
Inserção baixa sem complicações	O parto vaginal pode ser considerado em casos selecionados, após decisão compartilhada.

Tabela 1 — Conduta na placenta prévia conforme gravidade, idade gestacional e vitalidade fetal.

Dois pontos merecem atenção. A **tocólise** é [controverso]: o protocolo da Maternidade-Escola da UFRJ a contraindica, porque mascara os sinais de hipovolemia e pode agravar o sangramento, enquanto outros protocolos admitem seu uso quando há contrações num quadro estável. Em prova, a resposta esperada é não inibir o trabalho de parto na gestante que está sangrando. O segundo ponto é a **data do parto**: o protocolo da UFRJ indica cesárea eletiva com 37 a 38 semanas, mas a recomendação mais recente do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (2021) antecipa para 36+0 a 37+6 semanas. A lógica é programar a cesárea antes que o trabalho de parto espontâneo, ao formar o segmento e apagar o colo, provoque um sangramento de urgência.

Cesárea na placenta prévia

A técnica depende da posição da placenta. Placenta posterior, ou anterior sem acretismo, permite histerotomia segmentar transversa; se a placenta estiver sob a incisão, ela é descolada manualmente pelo menor caminho até as membranas. Segmento inferior não formado ou com vasos muito calibrosos pede incisão corporal; placenta anterior com suspeita de acretismo pede histerotomia corporal ou fúndica, longe da placenta. Mesmo sem acretismo, o **risco de hemorragia pós-parto é alto**: o leito placentário fica no segmento inferior, que tem pouca musculatura e contrai mal para comprimir os vasos.

Betametasona (ou dexametasona)

CORTICOIDE — ACELERA A MATURAÇÃO PULMONAR FETAL

INDICAÇÃO

Risco de parto entre 24 e 34 semanas: placenta prévia que sangrou, DPP em conduta expectante, vasa prévia, acretismo com parto programado.

DOSE E VIA

Betametasona 12 mg IM a cada 24 h, 2 doses; ou dexametasona 6 mg IM a cada 12 h, 4 doses.

POR QUE FUNCIONA

Induz a produção de surfactante e a maturação estrutural do pulmão fetal, reduzindo síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular e mortalidade neonatal.

CAUTELAS

Não atrasar o parto de urgência para completar o esquema. Entre 34 e 36 semanas, pode ser considerado se não houve curso anterior e o risco de parto é alto.

SUS

Disponível na rede hospitalar; ambos são medicamentos de uso corrente em maternidades.

Sulfato de magnésio — neuroproteção fetal

ANTAGONISTA DO CÁLCIO E DO RECEPTOR NMDA — REDUZ PARALISIA CEREBRAL NO PREMATURO EXTREMO

INDICAÇÃO

Parto pré-termo iminente antes de 32 semanas (até 31+6), inclusive quando o parto é indicado por causa materna ou fetal, como no sangramento.

DOSE E VIA

Ataque de 4 g IV em 30 minutos; manutenção de 1 g/h IV até o nascimento, por no máximo 24 horas.

CAUTELAS

Não adiar parto de urgência para administrá-lo. Suspender tocolíticos ao iniciar.

MONITORIZAÇÃO

Sinais vitais, reflexos patelares, frequência respiratória e diurese, como em qualquer uso de magnésio; cardiotocografia contínua. Antídoto: gluconato de cálcio.

SEÇÃO 3

Espectro da placenta acreta

É a placenta que não quer sair: quase nunca sangra antes do parto, mas pode provocar a hemorragia mais grave da obstetrícia quando alguém tenta descolá-la.

3.1 Conceito e mecanismo

Normalmente, entre as vilosidades coriais e o miométrio existe uma camada de decídua basal que serve de plano de clivagem: depois do nascimento, a placenta se separa por ali e o útero contrai sobre os vasos abertos. Onde há uma **cicatriz**, essa decídua se forma mal, e o trofoblasto entra em contato direto com o miométrio. Conforme a profundidade, fala-se em **acreta** (vilosidades aderidas ao miométrio), **increta** (penetram o miométrio) e **percreta** (atravessam a serosa e podem invadir bexiga e paramétrios). Sem plano de clivagem, a placenta não se solta; se for arrancada, deixa vasos abertos num miométrio que não consegue contrair sobre eles, e o sangramento é maciço.

3.2 Quem tem risco

O principal fator de risco é a combinação de **placenta prévia ou anterior baixa com cesárea anterior**, porque a placenta se implanta exatamente sobre a cicatriz. Na gestante com placenta prévia, o risco de acretismo cresce de forma acentuada com o número de cesáreas: cerca de 3% com uma, 11% com duas,

40% com três, 61% com quatro e 67% com cinco ou mais. Curetagens, miomectomias e outras cirurgias uterinas também aumentam o risco. A recorrência numa gestação futura é de 22% a 29%.

3.3 Diagnóstico pré-natal

O diagnóstico antes do parto muda o desfecho, porque permite planejar a cirurgia num centro preparado. A Febrasgo recomenda que **toda gestante com cirurgia uterina prévia e placenta anterior baixa** faça ultrassonografia dirigida entre 18 e 24 semanas, com bexiga moderadamente cheia; a sensibilidade e a especificidade passam de 90% nas mãos de examinadores experientes [FEBRASGO 2021]. Os sinais refletem a perda do plano entre placenta e útero:

- perda da zona hipoecoica retroplacentária e miométrio retroplacentário com menos de 1 mm;
- interface útero-bexiga irregular ou interrompida e abaulamento da placenta;
- lacunas intraplacentárias;
- ao Doppler, hipervascularização subplacentária e vasos que atravessam da placenta para a bexiga.

A ressonância magnética, sem gadolínio e de preferência entre 24 e 30 semanas, complementa a ultrassonografia na placenta posterior e na avaliação da profundidade da invasão e do acometimento de bexiga e paramétrios; seu papel global ainda é incerto.

3.4 Conduta

A gestante com suspeita de acretismo deve ter o parto num **centro terciário** com equipe multidisciplinar experiente, banco de sangue e UTI, porque a morbidade é menor nesses centros. Se estiver estável, o parto é programado entre **34+0 e 35+6 semanas**, com corticoide antenatal; antecipa-se diante de sangramento importante, rotura de membranas ou trabalho de parto [FEBRASGO 2021][ACOG 2021].

O princípio cirúrgico é **não tentar descolar a placenta**. A histerotomia é feita no fundo ou fora da área invadida, o feto é extraído e a placenta fica no lugar. A partir daí, as opções são a histerectomia com a placenta *in situ* — indicada quando há invasão de paramétrio, colo ou região istmocervical, com perda adicional de 2 a 3 litros e transfusão em cerca de 90% dos casos —, a exérese segmentar da área invadida com reconstrução uterina, preferida pela Febrasgo quando tecnicamente possível, ou, em casos selecionados, a manutenção da placenta *in situ* com seguimento por semanas a meses. O metotrexato não é mais recomendado.

> **ATENÇÃO**
> Diante de acretismo **não suspeitado** descoberto durante a cesárea, interrompa a dequitação: não tente remover a placenta, extraia o feto por histerotomia fora da área invadida, feche o útero com a placenta no lugar e planeje a cirurgia definitiva em centro preparado em 1 a 2 semanas, se a paciente estiver estável. A principal medida de prevenção do acretismo é **reduzir as cesáreas sem indicação**.

SEÇÃO 4

Descolamento prematuro de placenta

O sangue que fica preso atrás da placenta explica quase tudo no DPP: a dor, o útero duro, o sangue escuro, o feto em sofrimento e a coagulopatia.

4.1 Definição e epidemiologia

DPP é a separação, parcial ou total, de uma **placenta normalmente inserida**, a partir de 20 semanas e antes da expulsão do feto. Complica cerca de 1% dos nascimentos, e aproximadamente 80% dos casos acontecem antes do início do trabalho de parto. É uma das principais causas de morte perinatal.

4.2 Fatores de risco

A maior parte dos DPP nasce de uma doença da circulação uteroplacentária ou de um trauma mecânico. Por isso, os fatores de risco se agrupam:

- **Doença vascular placentária** — as **síndromes hipertensivas** respondem por até metade dos casos não traumáticos; tabagismo e **cocaína** (vasoconstrição) também entram aqui, assim como trombofilias.
- **DPP em gestação anterior** — o maior determinante isolado, que eleva o risco de 15 a 20 vezes.
- **Causas mecânicas** — trauma abdominal (inclusive acidente de trânsito), descompressão súbita do útero sobredistendido (rotura de membranas no polidrâmnio, parto do primeiro gemelar) e rotura prematura de membranas.
- **Outros** — idade materna avançada, multiparidade, corioamnionite e miomas.

4.3 Fisiopatologia

O evento inicial costuma ser a lesão das arteríolas da decídua basal, frequentemente doentes pela hipertensão. O sangue que extravasa forma um **hematoma retroplacentário** sob pressão arterial, que disseca o plano entre placenta e útero e amplia o descolamento. Como esse sangue fica parcialmente retido, ele coagula antes de sair: o sangramento externo é **escuro** e pode ser pequeno, e em 10% a 20% dos casos fica **totalmente oculto**. Por isso, o volume que sai pela vagina não mede a gravidade.

O hematoma irrita e distende o miométrio, que responde com contrações frequentes e aumento do tônus basal — a **hipertonia**, que torna o útero doloroso e "lenhoso" à palpação. Quando o sangue infiltra a parede muscular até a serosa, o útero fica arroxeado e perde a capacidade de contrair: é o **útero de Couvelaire**, ou apoplexia uteroplacentária, que predispõe à atonia pós-parto.

Para o feto, a área descolada simplesmente deixa de trocar gases, e a hipertonia comprime os vasos que irrigam o restante da placenta. O resultado é hipóxia, que aparece como cardiotocografia alterada, bradicardia e, nos casos graves, óbito fetal.

Para a mãe, há dois perigos. O primeiro é a hipovolemia, muitas vezes maior do que o sangramento visível sugere. O segundo é a **coagulopatia**: o coágulo retroplacentário consome fibrinogênio e plaquetas, e a tromboplastina liberada pela decídua lesada entra na circulação materna e ativa a coagulação de forma difusa, levando à coagulação intravascular disseminada. A hipoperfusão pode causar necrose tubular aguda e, no pós-parto, necrose hipofisária — a **síndrome de Sheehan**.

4.4 Quadro clínico e classificação

O quadro típico é **dor abdominal súbita**, de intensidade variável, com sangramento escuro (presente em cerca de 80% dos casos), útero hipertônico e doloroso, alteração da vitalidade fetal e, nos casos graves, sinais de choque e de coagulopatia, como petéquias e sangramento em locais de punção. Pode haver hemoâmnio quando as membranas se rompem. A classificação de Sher, usada nos protocolos brasileiros, organiza a gravidade (Tabela 2).

Grau	Mãe	Feto
I	Sangramento discreto ou ausente, sem hipertonia, sem alteração hemodinâmica ou de coagulação. Muitas vezes o diagnóstico é retrospectivo, pelo coágulo na face materna da placenta.	Vivo, sem comprometimento.
II	Sangramento moderado, hipertonia, taquicardia materna, alteração postural da pressão; queda inicial do fibrinogênio.	Vivo, com sinais de comprometimento.

Grau	Mãe	Feto
III	Hipertonia e hipotensão materna acentuada. **IIIA**: sem coagulopatia. **IIIB**: com coagulopatia.	Óbito fetal.

Tabela 2 — Classificação de Sher do descolamento prematuro de placenta. O que separa os graus II e III é a vida do feto.

4.5 Diagnóstico

O diagnóstico é **clínico**. A ultrassonografia serve para afastar placenta prévia e confirmar vitalidade ou óbito fetal; um exame normal **não exclui DPP**, porque o coágulo recente tem ecogenicidade parecida com a da placenta. Os exames laboratoriais não fazem o diagnóstico, mas guiam a conduta:

- **Fibrinogênio**: valor de 200 mg/dL ou menos tem valor preditivo positivo de 100% para hemorragia pós-parto grave; abaixo de 100 mg/dL indica coagulopatia de consumo.
- **Plaquetas abaixo de 100.000/mm³** com TTPa prolongado sugerem coagulação intravascular disseminada.
- **Prova do coágulo à beira do leito**: sangue em tubo seco deve coagular em 7 a 10 minutos; se não coagula, há coagulopatia — útil enquanto o laboratório não responde.
- Hemograma, ureia, creatinina e gasometria completam a avaliação; produtos de degradação da fibrina são o indicador mais sensível de consumo.

4.6 Conduta

Medidas gerais, em todos os graus: acessos calibrosos, sondagem vesical, oxigênio, monitorização contínua de pressão, frequência cardíaca e diurese, reserva de sangue e **reposição precoce** com cristaloide, concentrado de hemácias, plasma, crioprecipitado e plaquetas conforme os exames.

Amniotomia: é feita assim que possível, qualquer que seja a via de parto planejada. Ao esvaziar parte do líquido, diminui a pressão intrauterina, o que reduz a passagem de tromboplastina para a circulação materna, limita a progressão do descolamento, melhora a hipertonia e coordena as contrações, além de acelerar o trabalho de parto.

Via de parto — o que decide é a vida do feto e a estabilidade da mãe:

- **Feto vivo e viável**: via mais rápida, em geral **cesárea de urgência**. Se o parto vaginal for iminente — em período expulsivo, ou previsto em até cerca de 20 minutos diante de cardiotocografia categoria III —, o parto vaginal, inclusive instrumental, é aceitável.
- **Feto morto com mãe estável**: **parto vaginal**, com amniotomia e ocitocina, buscando o nascimento em 4 a 6 horas com reavaliação horária. A cesárea fica para a instabilidade materna ou a falha da indução.
- **Feto pré-termo, mãe e feto estáveis, sangramento sem risco de vida**: conduta expectante com internação, corticoide antes de 34 semanas e vigilância rigorosa é possível, mas o descolamento parcial pode progredir sem aviso [evidência limitada].

Útero de Couvelaire: não é, por si só, indicação de histerectomia. Trata-se a atonia com uterotônicos — ocitocina, metilergometrina, misoprostol 800 µg por via retal — e massagem; a histerectomia subtotal fica para o útero que não contrai apesar dessas medidas, e não deve ser adiada nesse cenário, mesmo em paciente jovem. No pós-parto, vigiar diurese e função renal e lembrar da síndrome de Sheehan na puérpera que não consegue amamentar.

> **PEGADINHA DE PROVA**
>
> Gestante hipertensa com dor abdominal e sangramento pequeno **não** tem um DPP leve: o sangue pode estar oculto. Ultrassonografia normal **não** afasta DPP. Feto morto **não** é indicação de cesárea — com a mãe estável, a via é vaginal. E útero de Couvelaire **não** é indicação automática de histerectomia.

SEÇÃO 5

Rotura uterina

Na rotura, o sinal mais fiel não é o sangramento vaginal — é o coração do feto que some no monitor.

5.1 Definição e fatores de risco

Rotura uterina é a solução de continuidade da parede do útero. É **completa** quando atravessa toda a espessura, incluindo o peritônio visceral, comunicando a cavidade uterina com a abdominal — uma emergência com risco para a mãe e o feto —, e **incompleta** quando o peritônio se mantém íntegro, situação em geral mais branda. Mais de 90% acontecem no segmento inferior anterior.

O grande fator de risco é a **cicatriz uterina**, sobretudo de cesárea. O tipo de incisão pesa muito: a cicatriz corporal (clássica) rompe em 4% a 9% das gestações seguintes, contra 0,2% a 1,5% da segmentar transversa. Na prova de trabalho de parto após uma cesárea, o risco é de cerca de 1%; após duas ou mais, de cerca de 2%. Outros fatores: miomectomia, perfuração em curetagem, acretismo, trauma, malformações e sobredistensão uterina, e o **uso inadequado de uterotônicos**. As prostaglandinas para preparo do colo não são recomendadas em quem tem cesárea anterior; a ocitocina, usada com cuidado, não aumenta o risco em comparação ao trabalho de parto espontâneo.

No útero sem cicatriz, a rotura é rara e costuma ser a consequência final do trabalho de parto obstruído — desproporção, apresentação anômala, contrações intensas contra um obstáculo —, em geral por falha de vigilância do trabalho de parto [prática consagrada].

5.2 Iminência de rotura

No trabalho de parto obstruído, o corpo uterino contrai cada vez mais e se espessa, enquanto o segmento inferior é estirado e afinado. A transição entre os dois forma um anel que sobe em direção ao umbigo e dá ao útero o aspecto de ampulheta — o **sinal de Bandl**. Os ligamentos redondos, tracionados, ficam tensos e palpáveis como cordas na parede abdominal — o **sinal de Frommel**. A paciente tem dor intensa e contínua, agitação e contrações subentrantes. É a **síndrome de Bandl-Frommel**, e o tratamento é parar o estímulo contrátil e fazer **cesárea imediata**, antes que o segmento se rompa [prática consagrada].

5.3 Rotura consumada

A rotura pode ocorrer antes, durante ou depois do trabalho de parto. O sinal mais característico durante o trabalho de parto é a **alteração súbita da frequência cardíaca fetal**, que evolui para bradicardia ou desaparecimento dos batimentos. Os demais achados decorrem da abertura do útero:

- dor súbita e intensa seguida de **parada das contrações** — o útero rompido deixa de funcionar como bomba;
- **subida da apresentação** ao toque, porque o feto escapa para a cavidade abdominal;
- **partes fetais facilmente palpáveis** sob a parede abdominal;
- choque hipovolêmico, com taquicardia e hipotensão, desproporcional ao sangramento vaginal, que pode ser pequeno ou ausente, porque o sangue vai para o peritônio.

O diagnóstico é clínico e confirmado na laparotomia. A conduta é ressuscitação e laparotomia imediata, de preferência sob anestesia geral, para não agravar a hipotensão. A correção depende da extensão da lesão, da estabilidade e do desejo reprodutivo: histerorrafia em duas ou três camadas quando possível, ou histerectomia quando a lesão vascular é extensa; lesões de bexiga e ureter pedem avaliação urológica. Na gestação seguinte, a cesárea é programada antes do trabalho de parto, entre **36 e 37 semanas** [ACOG 2021].

SEÇÃO 6

Vasa prévia e rotura do seio marginal

Dois sangramentos indolores e de sangue vivo, com prognósticos opostos: num, quem sangra é o feto; no outro, ninguém corre risco.

6.1 Vasa prévia

Na vasa prévia, **vasos fetais** correm pelas membranas, sem a proteção do cordão e da geleia de Wharton, sobre o orifício interno do colo ou a até 2 cm dele. Há dois tipos: no tipo 1, os vasos vêm de uma **inserção velamentosa do cordão**; no tipo 2, ligam os lobos de uma placenta bilobada ou um lobo sucenturiado ao disco principal. Os fatores de risco derivam disso: placenta baixa ou prévia no segundo trimestre, inserção velamentosa, placenta bilobada ou com lobo acessório, gestação múltipla e reprodução assistida.

O feto tem pouco sangue — por volta de 80 a 100 mL/kg —, de modo que um sangramento que pareceria pequeno para a mãe é uma exsanguinação para ele [prática consagrada]. Quando as membranas se rompem, espontaneamente ou por amniotomia, os vasos rompem junto. O quadro clássico é **sangramento vaginal indolor logo após a amniorrexe, com sofrimento fetal agudo**: bradicardia ou padrão sinusoidal na cardiotocografia, evoluindo para óbito em minutos. A mãe está estável. Sem diagnóstico pré-natal, a mortalidade fetal chega a 50% a 60%.

Por isso, o objetivo é **diagnosticar antes do parto**. A ultrassonografia transvaginal com Doppler colorido mostra vasos fetais fixos sobre o colo; o diagnóstico costuma ser feito entre 18 e 26 semanas, e cerca de 20% dos casos se resolvem no segundo trimestre. A diferença para o procúbito de cordão (apresentação funicular, com membranas íntegras) é que, neste, o cordão se afasta do colo durante o exame, enquanto os vasos prévios ficam fixos.

Conduta no diagnóstico pré-natal [SMFM 2015, reafirmado em 2024]:

- internação entre 30 e 34 semanas, decidida caso a caso (sangramento, contrações, distância do hospital);
- corticoide antenatal, considerado entre 28 e 32 semanas pelo risco de parto de urgência;
- **cesárea programada entre 34 e 37 semanas**, antes que as membranas se rompam [ACOG 2021];
- **cesárea de emergência** diante de trabalho de parto, rotura de membranas ou sangramento com alteração da frequência cardíaca fetal;
- parto em serviço capaz de transfundir o recém-nascido imediatamente, com sangue O negativo disponível.

> **ATENÇÃO**
> Nunca faça amniotomia sem conhecer a placenta e a inserção do cordão quando há placenta baixa ou suspeita de vasa prévia. Em sala de parto, a dúvida entre sangue materno e fetal pode ser esclarecida por testes que identificam hemoglobina fetal (como o de Apt ou o de Kleihauer), mas, com feto em sofrimento agudo, não se espera resultado: a conduta é a cesárea imediata [prática consagrada].

6.2 Rotura do seio marginal

O seio marginal é o anel venoso que contorna a borda da placenta. A sua rotura causa sangramento **materno**, de sangue vivo, **indolor**, geralmente no fim da gestação ou durante o trabalho de parto, numa placenta **normalmente inserida**. Por ser venoso e de baixa pressão, o sangramento é discreto e autolimitado, sem hipertonia e sem repercussão materna ou fetal. O diagnóstico é de exclusão — placenta normoinserida na ultrassonografia, útero com tônus normal e feto bem — e é confirmado após o parto pelo coágulo na borda da placenta. A conduta é expectante, e o parto vaginal é a regra [prática consagrada].

APÊNDICE · PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR · TUTORIA

Maria — problemas, metas e ações

Placenta prévia com sangramento ativo moderado em gestação pré-termo de 33 semanas, mãe estável e feto sem sofrimento

Maria, gestante de 33 semanas. Procura a maternidade com sangramento vaginal **vermelho vivo, súbito, sem desencadeante**, sem coágulos e de volume moderado, com dor leve e relato de que o bebê está **mexendo menos**. Ultrassonografia morfológica de 20 semanas já mostrava placenta baixa. Ao exame: estável, PA normal, FC 98 bpm, sem sinais de choque; tônus uterino normal, BCF normal, bolsa íntegra; especular sem causa local; toque não realizado. **Ultrassonografia transvaginal: placenta prévia "centro-total"** (recobre todo o orifício interno). Cardiotocografia **categoria I**, com contrações irregulares e fracas. Hb 11,2 g/dL; tipagem **O positivo**; reserva de sangue disponível; em uso de sulfato ferroso. Pergunta se vai ficar internada e se o bebê vai nascer agora.

1. Lista de problemas

#	Problema	Situação	Base
1	**Placenta prévia com sangramento ativo**	CONFIRMADO	Sangue vivo, súbito, indolor, útero mole; ultrassom transvaginal com placenta sobre o orifício interno
2	**Gestação pré-termo** (33 semanas) com risco de parto antecipado	CONFIRMADO	Sangramento por placenta prévia tende a se repetir e a piorar; pode exigir cesárea de urgência
3	**Diminuição dos movimentos fetais**	CONFIRMADO	Queixa materna; cardiotocografia categoria I tranquiliza, mas exige vigilância seriada
4	**Contrações irregulares** — trabalho de parto ou irritabilidade	A ESCLARECER	Contrações fracas e irregulares; colo não avaliado pelo toque; reavaliar dinâmica
5	**DPP associado** não totalmente afastado	A ESCLARECER	Dor leve e movimentos reduzidos; tônus normal e sangue vivo falam contra; ultrassom normal não exclui
6	**Risco de acretismo**	A ESCLARECER	Cesárea ou curetagem prévia não informadas; placenta prévia sobre cicatriz exige pesquisa
7	**Vasa prévia** não pesquisada	A ESCLARECER	Placenta baixa no segundo trimestre é fator de risco; falta Doppler da inserção do cordão
8	**Hemoglobina limítrofe** com sangramento em curso	CONFIRMADO	Hb 11,2 g/dL já em uso de ferro; novos episódios podem levar a anemia e transfusão
9	**Antecedentes incompletos**	A ESCLARECER	Faltam paridade, cesáreas, curetagens, hipertensão, tabagismo e drogas
10	**Medo e insegurança** quanto à internação e ao bebê	CONFIRMADO	Pergunta se fica internada e se o bebê vai nascer
11	**Rede de apoio, distância do hospital e trabalho**	A ESCLARECER	Definem se a alta pode ser discutida e como ela chega rápido se sangrar de novo

2. Metas

Meta	Prazo	Como se verifica
Mãe estável e sangramento controlado	Contínuo	Sinais vitais, contagem de absorventes, Hb seriada
Corticoide completo para maturação pulmonar	24 a 48 h	Esquema prescrito agora e registrado
Bem-estar fetal mantido	Diário	Cardiotocografia diária e percepção dos movimentos
DPP e trabalho de parto afastados	24 a 48 h	Tônus, dinâmica uterina, coagulograma com fibrinogênio
Acretismo e vasa prévia avaliados	Antes de programar o parto	Antecedentes completos e ultrassom com Doppler
Hb preservada e sangue disponível	Até o parto	Hemograma seriado; reserva mantida
Paciente e família entendem o plano e os sinais de alarme	Antes de qualquer alta	Ela explica com as próprias palavras quando voltar
Cesárea programada em hospital com banco de sangue	36+0 a 37+6 semanas	Data agendada e equipe avisada

LEITURA DO CASO — O QUE VEM PRIMEIRO

É uma placenta prévia que sangrou com 33 semanas, com mãe estável e feto bem: o caso é de **conduta expectante, internada**. Respondendo à Maria: ela fica internada, e o bebê não precisa nascer agora. O que decide o desfecho é não fazer toque, manter sangue disponível, dar o corticoide já, vigiar mãe e feto todos os dias e ter critérios claros para a cesárea de urgência. O caso acertou ao não fazer o toque e ao confirmar a placenta pela via transvaginal.

3. Ações

CURTO PRAZO *Internação, primeiras 48 a 72 horas*

Estabilização

- Interno em leito obstétrico de alto risco; acesso venoso periférico calibroso.
- Repouso relativo; contraindico toque vaginal e relação sexual.
- Mantenho a reserva de concentrado de hemácias.
- Jejum só se o sangramento aumentar ou a cesárea ficar próxima.

Exames

- Hemograma, coagulograma com fibrinogênio, ureia e creatinina; hemograma seriado.
- Cardiotocografia diária e quando ela relatar menos movimentos.
- Ultrassom com Doppler: inserção do cordão (vasa prévia) e interface placenta-útero (acretismo).

Completar a anamnese

- Paridade, cesáreas, curetagens e cirurgias uterinas; hipertensão, tabagismo, drogas; perda de líquido.

Prescrições

- **Betametasona** 12 mg IM, 2 doses com 24 h de intervalo — **agora**; alternativa: dexametasona 6 mg IM de 12/12 h, 4 doses. Uma ou outra.
- **Sulfato de magnésio: não** — acima de 32 semanas.
- **Imunoglobulina anti-D: não** — O positivo.
- **Tocólise: não** de rotina — contrações fracas, sem trabalho de parto, e ela pode mascarar a hipovolemia.
- Mantenho sulfato ferroso; analgesia simples se dor.

Vigilância

- Sinais vitais e quantificação do sangramento seriados; tônus e dinâmica uterina.
- **Cesárea de urgência** se sangramento intenso, instabilidade materna, sofrimento fetal, trabalho de parto ou sinais de DPP.

Comunicação

- Explico à Maria e ao acompanhante o diagnóstico, por que ela fica internada, que o bebê está bem e que o parto será programado.

MÉDIO PRAZO *Até o parto programado*

- Alta discutida caso a caso só se o sangramento cessar e ela estiver estável, morar perto, tiver acompanhante e transporte; senão, permanece internada.
- Sinais de alarme para voltar já: sangramento, dor, contrações, perda de líquido, bebê mexendo menos.
- Pré-natal de alto risco com retornos curtos e Hb seriada.
- **Cesárea eletiva entre 36+0 e 37+6 semanas**, em hospital com banco de sangue.
- Se acretismo: centro terciário, parto com 34+0 a 35+6 semanas. Se vasa prévia: cesárea com 34 a 37 semanas.
- Psicologia e serviço social: ansiedade, afastamento do trabalho e apoio familiar.

LONGO PRAZO *Parto, puerpério e atenção primária*

- Cesárea com equipe experiente, sangue disponível e uterotônicos prontos: o leito placentário no segmento inferior contrai mal e aumenta o risco de hemorragia pós-parto.
- Pediatra na sala: recém-nascido pré-termo tardio ou de termo precoce.
- Puerpério na UBS: Hb e ferro, amamentação, contracepção e intervalo entre gestações.
- Orientar que a cesárea aumenta o risco de placenta prévia e de acretismo na próxima gestação: avaliar a placenta cedo no próximo pré-natal.

PONTOS PARA LEVANTAR NA TUTORIA

1. **"Centro-total"** é a classificação antiga; hoje é **placenta prévia** (recobre o orifício) ou **inserção baixa** (borda a menos de 20 mm).
2. **O corticoide é para agora**: a janela de rotina fecha em 34 semanas e o efeito começa em cerca de 24 horas. Não se adia o parto de urgência para completar o esquema.
3. **Magnésio e anti-D não entram** — 33 semanas e O positivo — e vale dizer isso em voz alta.
4. **Antecedente de cesárea muda o caso**: é a pergunta que falta e a porta para o acretismo.
5. **A data da cesárea é 36 a 37+6 semanas**, não 39: o objetivo é operar antes que o trabalho de parto provoque um sangramento de urgência.

Base: protocolo de hemorragias da segunda metade da gestação do HUAB-UFRN/Ebserh, Manual MSD (placenta prévia), Maternidade-Escola da UFRJ, Febrasgo (espectro da placenta acreta, 2021) e ACOG (momento do parto, 2021), as mesmas fontes do resumo. As condutas devem ser ajustadas ao exame à beira do leito e aos protocolos do serviço.